

Sepse neonatal - precoce e tardia

Sepse neonatal precoce ("d72 h) liga-se a colonização perinatal (GBS, enterobactérias, Listeria). A tardia relaciona-se a ambiente/procedimentos (estafilococos, Gram"). Trate empiricamente sem atrasar coleta.

Sinais inespecíficos

Dica - Sinais inespecíficos

Recém-nascido 'não parece bem': apneia, letargia, má perfusão, hipotermia ou febre, distensão, glicemia instável. Não espere foco óbvio.

Ramificação etiológica clássica guia o ATB empírico e a investigação de foco.



Abordagem

- Culturas (hemocultura ± LCR conforme indicação) antes do ATB, sem atrasar
- ATB empírico precoce clássico: ampicilina + aminoglicosídeo
- Avaliar TORCH/meningite se clínica; suporte hemodinâmico e glicemia
- Fatores de risco precoce: CORIO, RPM prolongada, GBS materno, prematuridade

Tempo e germe

Janela | Germes típicos

Precoce | Streptococcus agalactiae, E. coli, Listeria

Tardia | S. epidermidis, S. aureus, Gram" hospitalares

Associada a cateter | Coagulase-negativos / Candida

Armadilha de prova

Atenção - Armadilha de prova

Listeria não é coberta por cefalosporina isolada. No esquema precoce, ampicilina (ou equivalente com atividade) é o ponto que a banca cobra.